病毒性角膜内皮炎｜诊疗流程

中国专家共识 2023 · 条件、阈值与下一步 · p 为期刊页码（PDF 页码 =p−12）

依据 1：急性起病，感染史 / 诱因可有；依据 3：基质水肿、水肿区 KP 、后弹力层皱褶
符合 1 和 3 → 临床诊断；不符合 → 鉴别前葡萄膜炎、基质炎、失代偿、 Fuchs/Chandler 、排斥、急闭〔2023 p15–16〕

↓

IVCM + 房水 PCR；必要时特异抗体／ G-W 系数 → 依据 1 、 3 和 4 或 5 作病因诊断
PCR 阳性 → 确认所检病毒；猫头鹰眼 → 原文 CMV 依据； PCR 阴性 → 不能排除，结合临床〔2023 p14–15〕

↓

HSV 〔2023 p16〕
全身／眼部阿昔洛韦或更昔洛韦

CMV 〔2023 p16–17〕
首选更昔洛韦；阿昔洛韦无效

VZV 〔2023 p17〕
全身更昔洛韦 / 泛昔洛韦等；局部更昔洛韦

↓

按伴随情况分支〔2023 p17〕
在有效抗病毒基础上 → 联合眼部激素；眼压升高 → 降压（慎用前列腺素）；严重内皮失代偿 → 移植及围术期抗病毒

↓

更昔洛韦安全监测〔2023 p16〕
用前血常规 / 肝肾；诱导血常规每 3 d 、肝肾每周；维持血常规每周、肝肾每 2~4 周。
肝肾恶化／血小板≤ 25×10^9/L ／粒细胞≤ 0.5×10^9/L 或降至用前 50% → 停药。
治疗 3 周无效 → 考虑耐药，改膦甲酸钠。

恢复与复发管理〔2023 p14 、 17〕
羊脂 / 尘状 KP 消退 → 激素每周减 1 次，至 1 次 /d 后按炎症调整。
眼压正常 → 降压药减停；术后全身抗病毒通常 3~6 个月。
监测 KP/ 炎症、眼压与内皮； CMV 易复发者适当延长治疗。

原文未明确： PCR/G-W/ 眼压处置阈值、正式危险评分、统一复诊间隔、 VZV“更高剂量”阿昔洛韦及膦甲酸钠剂量。